

ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ – ΗΜΙΚΡΑΝΙΑ

Γενικά: Η Κεφαλαλγία οφείλεται στον ερεθισμό των ευαίσθητων στον πόνο ανατομικών ενδοκράνιων σχηματισμών ή των ανατομικών στοιχείων της κεφαλής και του αυχένα.

Μηχανισμοί πρόκλησης κεφαλαλγίας, μπορεί να είναι τα ακόλουθα: αυξημένη μυϊκή τάση, σύσπαση - θλάση περικρανιακών μυών, φλεγμονή και πίεση μηνίγγων, αύξηση ενδοκράνιας πίεσης, έλξη-διάταση-σύσπαση των ενδοκράνιων αλλά και εξωκράνιων αγγείων, πίεση των κρανιακών και νωτιαίων νεύρων. Ας μη ξεχνάμε βέβαια ό,τι ο εγκέφαλος δεν πονάει!

Με βάση και τα ανωτέρω, η κεφαλαλγία μπορεί να προκαλείται από τα εξής:

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| ▶ Νευρολογικές παθήσεις | ▶ Οδοντιατρικές παθήσεις |
| ▶ Ωτολογικές παθήσεις | ▶ Συστηματικές παθήσεις |
| ▶ Οφθαλμολογικές παθήσεις | ▶ Αϋπνία, έντονη σωματική άσκηση. |

Κλινική εξέταση: Ο χρόνος και ο τρόπος έναρξης της κεφαλαλγίας είναι σημαντικοί για τη διάγνωση. Οξεία εγκατάσταση έντονης κεφαλαλγίας θέτει την υποψία αγγειακής βλάβης (υπαραχνοειδής αιμορραγία, ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, αιμορραγία όγκου του εγκεφάλου). Εξετάζουμε αν η κεφαλαλγία είναι εντοπισμένη, καθώς και για την ύπαρξη άλλων σοβαρών συνοδών καταστάσεων (πυρετός, νεόπλασμα, HIV, κύηση, σπασμοί, έναρξη μετά τα 50 έτη).

Η ημικρανία φαίνεται να παρουσιάζει ισχυρό γενετικό υπόστρωμα. Συνήθως, ο πόνος της ημικρανίας είναι παλμικός και ρυθμικός. Μόνο στο 30% των ασθενών προηγείται αύρα, με φωταψίες ή σκοτώματα, οπτικές, ακουστικές ή οσφρητικές ψευδαισθήσεις.

Αδρή νευρολογική εκτίμηση: Έλεγχος για μηνιγγικά σημεία. Έλεγχος για εστιακά σημεία. Έλεγχος για ύπαρξη άλλων συνοδών συμπτωμάτων π.χ. ναυτία-έμετος, θάμβος οράσεως, φωτοευαισθησία, ηχοευαισθησία, δυσαρθρία, αιμωδίες/παραίσθησιες ή παρέσεις άκρων.

Τα βασικά κλινικά χαρακτηριστικά του πόνου στην ημικρανία, είναι:

- ✓ **Ένταση:** Μέτρια έως μεγάλη. Επιδείνωση με τη σωματική δραστηριότητα.
- ✓ **Εντόπιση:** Ετερόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη, μετωπιαία, ινιακή ή γενικευμένη· συχνά με επίκεντρο τον οφθαλμικό κόγχο και ακτινική επέκταση περίξ του οφθαλμού.
- ✓ **Ποιότητα:** Σφύζων χαρακτήρας, σπανιότερα συσφιγκτικός.
- ✓ **Διάρκεια:** Συνήθως 4-24 ώρες. Σπάνια φτάνει τις 48-72 ώρες.
- ✓ **Ύφεση:** Συνήθως υφίεται με την κατάκλιση και τον νυκτερινό ύπνο.
- ✓ **Συνοδά συμπτώματα:** Ναυτία ή/και έμετος, ευαισθησία και δυσανεξία στα αισθητικά ερεθίσματα, φωτοφοβία, ηχοφοβία, απτοφοβία, οσμοφοβία, κ.ά.

Διαφορική διάγνωση: Πρέπει να αποκλείσουμε νοσήματα ή διαταραχές, όπως μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα, ΑΕΕ, OEM, υπογλυκαιμία, ηλεκτρολυτικές διαταραχές, φαιοχρωμοκύττωμα, οξεία παραρρινοκολπίτιδα, εστιακή επιληψία, σοβαρή αναιμία, αγγειακές δυσπλασίες, αγγειίτιδα του ΚΝΣ, κροταφική αρτηρίτιδα, μετά από οσφυονωτιαία παρακέντηση (ONΠ), ενδοκράνιοι όγκοι (π.χ. αναπλαστικό ολιγοδενδρογλοίωμα), οξύ γλαύκωμα, κ.λπ.

Οι περιπτώσεις Κεφαλαλγίας που θα απαιτήσουν εργαστηριακό και πιθανώς απεικονιστικό έλεγχο (CT ή MRI εγκεφάλου ή MRA ενδοκράνιων αγγείων) ή παραπομπή σε νοσοκομείο ή σε κάποιο ειδικό Κέντρο ή Ιατρείο Κεφαλαλγίας, είναι αυτές στις οποίες έχουμε:

- Ύποπτα ευρήματα στη κλινική εξέταση (ναυτία/έμετοι, οίδημα οπτικής θηλής, κ.ά.).
- Έναρξη εμμένουσας κεφαλαλγίας, για πρώτη φορά, μετά την ηλικία των 50 ετών.
- Αιφνίδια, έντονη κεφαλαλγία, χωρίς ατομικό ιστορικό κεφαλαλγιών ή μετά από τραύμα.
- Κεφαλαλγία συνοδευόμενη από διαταραχές του επιπέδου συνείδησης.
- Κεφαλαλγία συνοδευόμενη από διαταραχές της συμπεριφοράς.
- Συνύπαρξη κεφαλαλγίας και επιληψίας.
- Επεισοδική, αυστηρά ετερόπλευρη κεφαλαλγία.
- Αλλαγή των χαρακτήρων της κεφαλαλγίας σε χρόνιο κεφαλαλγικό ασθενή.
- Προοδευτική επιδείνωση της έντασης και της βαρύτητας της κεφαλαλγίας.
- Κεφαλαλγία που εκλύεται ή επιδεινώνεται με το βήχα ή την καταβολή προσπάθειας.
- Κεφαλαλγία σε ασθενή με συννοσηρότητες (από το αναπνευστικό σύστημα ή επί HIV).

Θεραπευτική παρέμβαση

A. Σε κεφαλαλγία τάσεως ή ήπια ημικρανία:

1. Τοποθετούμε 3way φλεβική γραμμή και χορηγούμε 1 fl. 100 ml *Apotel* 1 gr, ταυτόχρονα με 1 amp. *Dynastat* 40 mg σε ορό 250 ml NaCl 0,9%, για έγχυση εντός 10-15 λεπτών. Εναλλακτικά, χορηγείται 1 fl *Combogesic* (1g/300mg), σε έγχυση εντός 10-15 λεπτών.
2. Εάν ο ασθενής έχει ιστορικό πεπτικού έλκους ή ΓΟΠΝ, τότε παράλληλα με το ΜΣΑΦ, χορηγούμε 1-2 amp. Σιμετιδίνη (*Tagamet*) στάγδην ή/και 1 amp. PPI (*Nexium*) iv-bolus.
3. Επί εμφανίσεως ναυτίας και εμέτων, προσθέτουμε 1 amp. *Primperan* ή 1 amp. *Onda* (iv).
4. Σε περίπτωση που ο ασθενής παραπονιέται και για συνοδό ίλιγγο ή ζάλη, τότε μπορούμε να χορηγήσουμε επιπρόσθετα 1 amp. *Vomex-A* (ενδομυικά-im) ή 1 tab. *Vertigo-N* (po).
5. Αν δεν είναι εφικτή η φλεβική πρόσβαση, μπορούμε να χορηγήσουμε ως δόση εφόδου:
 - 1-2 tabs. *Zaldiar/Algotra* (325+37,5) mg (Παρακεταμόλη + Τραμαδόλη), per os, ή
 - 1 amp. *Apotel-plus* (600+20) mg, μαζί με 1 amp. *Musco-Ril* 4 mg, (im), ή
 - 1 amp. *Voltaren* 75 mg ή *Viaxal* 50 mg, μαζί με 1 amp. *Norflex* 60 mg, (im), ή
 - 10 mg (2,5 ml) ή 20 mg (5 ml) oral. sol. *Errkes* (Κετορολόκη), per os (po).

B. Σε διαγνωσμένη επαναλαμβανόμενη ημικρανία:

1. Χορηγούμε **Σουματριπτάνη**, ήτοι 1 amp. *Imigran* 6 mg (sc). Επί υποτροπής, επανάληψη της δόσης μετά από 1 ώρα, με μέγιστη χορηγούμενη δόση 12 mg (2 ενέσεις) σε 24 ώρες. Εναλλακτικά, χορηγούμε 1 tab. *Imigran* 50 mg (po). Επί υποτροπής, επανάληψη δόσης μετά από 1 ώρα, με μέγιστη χορήγηση 300 mg /24h. Ομοίως, για άμεση δράση, μπορεί να χορηγηθεί **Ελετριπτάνη**, tab. *Relpax* 20-40 mg (po) και επανάληψη μετά από 2 ώρες.
2. Εναλλακτικά, χορηγούμε **Διυδροεργοταμίνη (DHE)**, ήτοι 1 tab. *Dihydergot* 2,5 mg (po), αφού προηγηθεί χορήγηση 1 amp. *Primperan* ή 1 amp. *Onda* (iv), προς αποφυγή εμέτου.
3. Αντ' αυτών, δίδεται (**Εργοταμίνη + Καφεΐνη**) από το ορθό, supp. *Cafergot* (2/100) mg. Επί υποτροπής / επιμονής της ημικρανίας, επαναλαμβάνεται η χορήγηση της ανωτέρω δόσης του *Cafergot*, μετά από 2-3 ώρες, με μέγιστη δόση τα δύο (2) υπόθετα /24ωρο.
4. Επί αποτυχίας όλων των παραπάνω, χορηγούμε ½ - 1 amp. *Romidon* ή *Tramadol* (im).

Γ. Προφυλακτική αγωγή κατ' οίκον:

- ★ Στη χρόνια φάση, το σημαντικότερο μέρος της θεραπείας είναι η πρόληψη των κρίσεων. Αυτό μπορεί να επηρεάσει θετικά τη ζωή των ασθενών με ημικρανία. Γενική αρχή στη χορήγηση των φαρμάκων προφύλαξης από την ημικρανία, είναι: **“start low, go slow”**.
- 1. **Ριζατριπτάνη**: tab. *Maxalt* 10 mg, επιγλωσσίως, για λήψη ευθύς μόλις αρχίσει η κρίση.
- 2. Εναλλακτικώς, **Σουματριπτάνη**: 1 amp. *Imigran* 6 mg, σε συσκευή για υποδόρια ένεση. (Προσοχή στις ανεπιθύμητες ενέργειες και στις αντενδείξεις της Σουματριπτάνης, ήτοι σε ασθενείς > 65 ετών, μη ελεγχόμενη ΑΥ-ΣΝ, ηπατική ανεπάρκεια, ισχαιμία του ΚΝΣ, κ.ά.).
- 3. Προφυλακτική χορήγηση β-blocker: (tab. *Inderal* 40 mg x3 ή tab. *Lopressor* 25 mg x2).
- 4. Προφυλακτική χορήγηση Τοπιραμάτης (*Topamac*) tab. 25 mg έως και 100 mg /ημέρα.
- 5. Χορήγηση αντικαταθλιπτικού τύπου SSRI (Βενλαφαζίνη-*Efexor*, Φλουοξετίνη-*Ladose*).
- 6. Επικουρικά χορηγείται: Μαγνήσιο, Ριβοφλαβίνη (vit. B2), Μελατονίνη, Συνένζυμο Q10.
- 7. Αποφυγή τροφίμων και ποτών τα οποία δυνητικά εκλύουν επεισόδια ημικρανίας, όπως: κόκκινο κρασί, μπύρα, σοκολάτα, καφές, ασπαρτάμη, σύκα, μπανάνα, πολύ ώριμα τυριά (ροκφόρ, γκούντα, τσένταρ, παρμεζάνα), σόγια, τουρσί, φάβα, αλλαντικά, κρεμμύδι, κ.λπ.

★ **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε κάθε αλλαγή του χαρακτήρα της κεφαλαλγίας ή σε επιμονή ή επίταση ενός χρόνιου πονοκεφάλου, πρέπει να γίνει άμεσα παραπομπή σε νευρολόγο, ώστε να αποκλείσουμε την πιθανότητα (ακόμα και με τη διενέργεια αξονικής-CT ή μαγνητικής-MRI τομογραφίας) ενός σοβαρού αιτίου, π.χ. όγκου του εγκεφάλου ή ανευρύσματος ενδοκράνιου αγγείου. Προτρέπουμε τον ασθενή να επισκεφθεί κάποιο ειδικό ιατρείο κεφαλαλγίας ή ειδικό επί της νόσου νευρολόγο.